La seguridad social en las Américas en el primer cuarto del siglo XXI

Avances, transformaciones y desafíos persistentes

Héctor Juan Villarreal Páez

ITED · Escuela de Gobierno y Transformación Pública · Tecnológico de Monterrey
CONOSAFI · Comunidad Latinoamericana de Conocimiento en Sistemas de Salud y Financiamiento

Conferencia magistral de apertura
Congreso de la Red Internacional de Investigación en Seguridad Social (RIUSS)
CIESS, Auditorio Benito Coquet, Ciudad de México · 12 de noviembre de 2026

Tesis y ruta

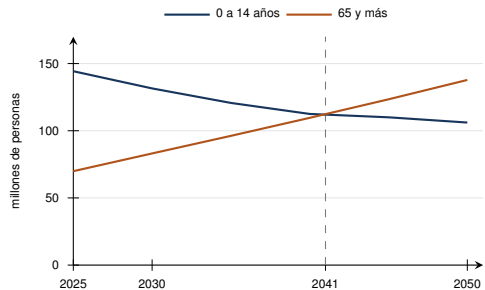
En 25 años la región amplió la cobertura como nunca; no resolvió cómo pagarla durante la transición demográfica.

Voy a recorrer cinco temas:

1. La **demografía** de la región, que ya está definida para las próximas décadas.
2. Las **pensiones**: lo que avanzó, lo que cambió y lo que sigue pendiente.
3. La **salud** y la **formalización**, con México como ejemplo del espacio fiscal.
4. Una **propuesta** de aseguramiento.
5. **CONOSAFI**, una comunidad regional para estudiar cómo se paga todo esto.

América Latina: menores de 15 y mayores de 65

- En América Latina y el Caribe, la población de 65 años y más pasará de **70 millones** en 2025 a **138 millones** en 2050.
- Hacia **2041** habrá más personas de 65 y más que menores de 15 años.
- Las personas de 80 y más casi se triplican: de **13** a **37 millones**. Es el grupo que más gasta en salud y en cuidados.

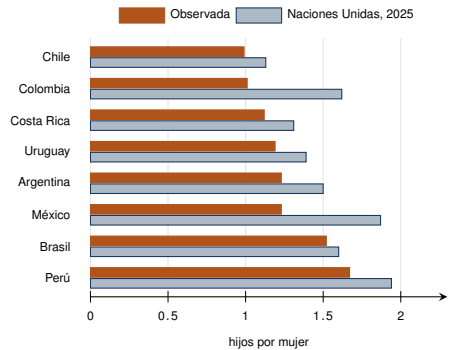


Proyección propia para 49 países y territorios, con la fecundidad de cada país fija en su último valor observado. Población base y mortalidad: ONU, WPP 2024; México: INEGI, Encuesta Intercensal 2025. Detalle al final.

La fecundidad cae más rápido de lo previsto

- En los registros más recientes, Chile tiene **0.99** hijos por mujer, Colombia **1.01**, Costa Rica **1.12**, y Argentina y México **1.23**.
- Ponderada por población, la región está en alrededor de **1.5** hijos por mujer. Para los mismos países, Naciones Unidas estima **1.77** en 2025.
- Fernández-Villaverde ha mostrado que las proyecciones oficiales tienden a sobreestimar la fecundidad.

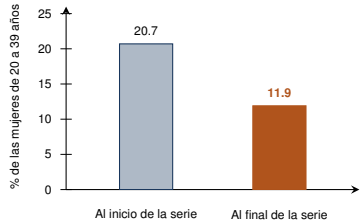
Por eso aquí usamos una proyección propia, con la fecundidad observada en cada país. Para 2050 da **699 millones** de habitantes en la región; Naciones Unidas espera 730.



Observada: registros nacionales de 2022 a 2025 reunidos por Fernández-Villaverde (2026); México: INEGI, Encuesta Intercensal 2025. Naciones Unidas: WPP 2024, variante media. Fernández-Villaverde (2023).

Por qué cayó tan rápido, y por qué no esperamos un rebote

- En Costa Rica la fecundidad pasó de **1.83** hijos por mujer en 2010 a **1.12** en 2024. En Colombia, de **1.7** a **1.1** en menos de una década.
- No es un efecto de las cuentas: los nacimientos cayeron entre **18** y **47 %** mientras crecía el número de mujeres en edad fértil.
- Lo que cambió fue la composición de las parejas. En Colombia casi no cambió la proporción de mujeres de 20 a 39 años que vive en pareja, pero las casadas pasaron de **20.7** a **11.9 %**.
- No encontramos un contagio dentro de cada generación, sino **reemplazo de generaciones**: cada una llega con menor propensión a casarse, y la conserva.



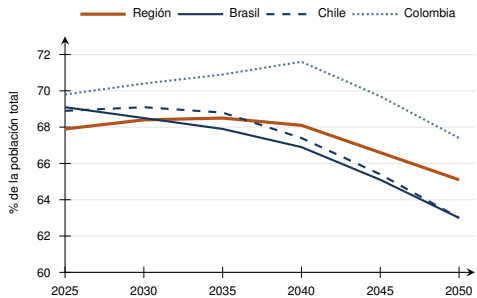
Colombia: mujeres casadas. Encuesta de hogares, 2008–2024.

Una caída así es persistente. Por eso mantenemos la fecundidad observada.

Villarreal (2026), «Cohort Replacement, Not Cascade», documento de trabajo, con registros vitales de INEC y DANE y encuestas de hogares del DANE.

La ventana demográfica se cierra

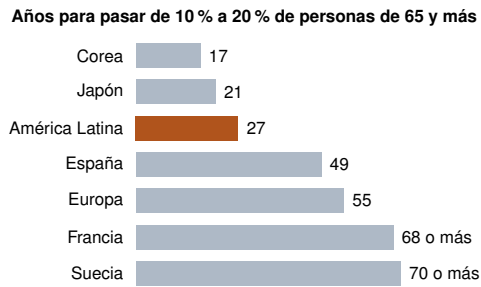
- En la región, la población de 15 a 64 años es hoy **67.9 %** del total y llega a su máximo, **68.5 %**, hacia **2035**. Ese último aumento viene de que hay menos niños, no de que haya más trabajadores.
- Después baja: **65.1 %** en 2050.
- Los países no van al mismo paso. Brasil ya va de bajada, Chile llega a su máximo hacia 2030 y Colombia hacia 2040. En 2050, Brasil y Chile estarán en **63 %**.



Proyección propia para 49 países y territorios, con la fecundidad de cada país fija en su último valor observado. Población base y mortalidad: ONU, WPP 2024; México: INEGI, Encuesta Intercensal 2025. Detalle al final.

Envejecer antes de ser ricos

- Europa tardó **55 años** en pasar de 10 % a 20 % de población de 65 años y más. Francia y Suecia tardaron todavía más.
- América Latina y el Caribe hará ese mismo recorrido en alrededor de **27 años**, entre 2024 y 2051.
- La región envejece antes de alcanzar el ingreso con el que otros países construyeron sus estados de bienestar. Tendrá menos tiempo y menos recursos para adaptar sus sistemas de pensiones, salud y cuidados.



Cálculo propio con ONU, WPP 2024 (después de 2023 es proyección); América Latina y el Caribe: proyección propia. Francia y Suecia ya pasaban de 10 % en 1950, inicio de la serie.

- En México, las enfermedades no transmisibles ya explican **60.1 %** de los años de vida perdidos por muerte prematura o discapacidad.
- Diabetes, hipertensión, cáncer: son padecimientos crónicos que se atienden durante años.
- El IMSS calcula que su prima de equilibrio para atención médica tendría que subir **34 %** para cubrir sus gastos.

Esta presión va a crecer con o sin reforma. Viene de la demografía y del perfil epidemiológico, y pasa lo mismo en el resto de la región.

CIEP (2026), *Implicaciones del Paquete Económico 2027*, con base en IHME, OMS e IMSS.

Esto ya no depende de nosotros.

Lo que sigue, sí.

Avances: la expansión no contributiva

- En este cuarto de siglo, el mayor avance en la protección de la vejez vino de las **pensiones no contributivas**. Ampliaron la cobertura de manera real y llegaron a personas que nunca habrían reunido las cotizaciones de una pensión contributiva.
- Se hizo por dos caminos: como piso focalizado en algunos países y como beneficio universal en otros.
- En los dos casos el costo fiscal crece cada año, con el número de personas mayores. Y si la pensión no contributiva no se integra con la contributiva, puede debilitar el incentivo a cotizar.

El gran avance del cuarto de siglo fue no contributivo: se amplió la cobertura sin ampliar la base que la paga.

Villarreal (2026), «América Latina necesita una nueva seguridad social», XXXVIII Seminario Regional de Política Fiscal, CEPAL, Santiago.

Transformaciones: el péndulo de las reformas



Línea de tiempo sin escala.

La región pasó de reformar parámetros, o de ir y venir entre modelos, a preguntarse por la arquitectura.

Leyes de reforma de cada país. Chile, 2025: Ley 21.735. Colombia, 2024: Ley 2381.

Chile 2025 y Colombia 2024: dos respuestas al mismo problema

Chile: Ley 21.735 (marzo de 2025)

Nueva cotización del empleador de **7 %** de la renta imponible. Es gradual: un punto desde agosto de 2025 y completa en 9 años, extensible a 11.

Con el 1.5 % del seguro de invalidez y sobrevivencia suma **8.5 %**: 4.5 % va al ahorro individual y 4 % a un nuevo Seguro Social.

La Pensión Garantizada Universal sube a 250 mil pesos, de forma escalonada por edad, entre septiembre de 2025 y septiembre de 2027.

Colombia: Ley 2381 de 2024

Crea un **sistema de pilares**.

En agosto de 2026 la Corte Constitucional declaró exequible la mayor parte de la reforma y devolvió nueve artículos a la Cámara para subsanar vicios de trámite.

La entrada en vigor está prevista para el **1 de abril de 2027**.

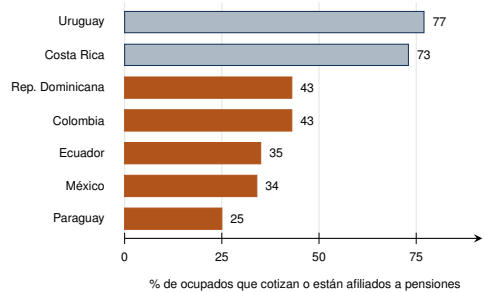
Las dos combinan un componente solidario con el ahorro individual.

Chile: Ley 21.735; Ministerio de Hacienda de Chile, 2025. Colombia: Ley 2381 de 2024; Corte Constitucional de Colombia, 2026.

Lo que sigue pendiente en pensiones

- **Suficiencia.** Falta saber qué pensión tendrá la generación que se retira sólo con su cuenta individual.
- **Cobertura contributiva.** En México, Colombia, Ecuador, Paraguay y República Dominicana cotiza o está afiliada menos de la mitad de los ocupados. Costa Rica y Uruguay son la excepción.
- **Informalidad.** Cerca de la mitad del empleo de la región es informal: **46.7 %** en 2025, con diferencias enormes entre países.

Las promesas de pensión maduraron antes de que se ampliara la base que cotiza.



CEPALSTAT, ocupados que aportan o están afiliados a sistemas de pensiones, 2023–2024. OIT, *Panorama Laboral 2025*: informalidad, primer semestre de 2025, promedio de 12 países. Villarreal (2026), CEPAL.

Una arquitectura multipilar

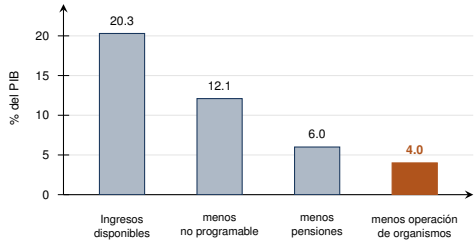


«El cero se habla con el uno, el dos con el tres.»

- El piso no contributivo y la pensión contributiva se diseñan juntos, para que cada año cotizado sume a lo que la persona recibe.
- El ahorro obligatorio y el voluntario comparten cuentas, reglas e incentivos.
- Cuando cada pilar se reforma por separado, uno termina por debilitar al otro.

- En México, los ingresos disponibles del sector público son **20.3 %** del PIB. Dejamos fuera el petróleo: lo que entra por el Fondo Mexicano del Petróleo (0.7) sale, en buena parte, como apoyo a Pemex (0.5).
- Les restamos lo que no se decide año con año: gasto no programable, pensiones y la operación propia de IMSS, ISSSTE y CFE.
- Queda **4.0 %** del PIB, más deuda, para salud, educación, infraestructura, seguridad, cuidados y todo lo demás.

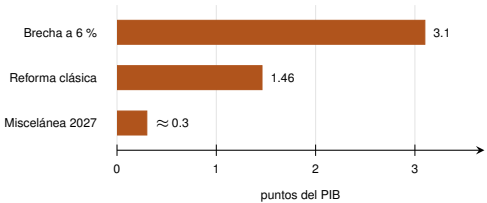
Son sólo sumas y restas, sin supuestos de comportamiento. Y 4.0 % es el máximo.



Restas: no programable 8.2 (costo financiero 3.8, participaciones 4.2, Adefas 0.2); pensiones 6.1; operación propia 2.1. El resultado sin redondear es 3.95; con las cifras redondeadas la resta da 3.9.

Villarreal, *Contabilidad de la Muerte*, actualización 2026, con SHCP, Informe enero–septiembre 2026.

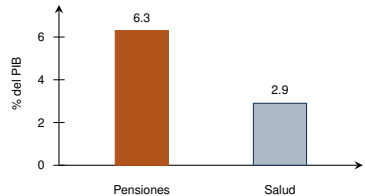
- En 2027 el gasto público en salud sería **2.9 %** del PIB. Para llegar al 6 % que recomienda la OPS faltan **3.1** puntos.
- Una reforma fiscal clásica completa (IVA, ISR y gastos fiscales) daría alrededor de **1.5** puntos.
- La Miscelánea 2027 aporta alrededor de **0.3** puntos.



Una reforma fiscal ambiciosa, por sí sola, no alcanza para financiar la salud universal.

CIEP (2026); OPS (2014); estimación propia del paquete de reforma clásica. Miscelánea: estimación previa a las exclusiones aprobadas por el Senado; el rendimiento final es algo menor. Detalle de fuentes al final.

- El PEF 2027 asigna **6.3 %** del PIB a pensiones y **2.9 %** a salud: más de dos pesos a pensiones por cada peso a salud.
- Las pensiones contributivas crecen **4.7 %** real, sobre todo por IMSS e ISSSTE. Es gasto comprometido desde hace años.
- Si no aumentan los ingresos, cada punto adicional en pensiones es un punto menos para salud.



En toda la región, cada punto adicional en pensiones compite con la salud.

PEF 2027 (dictamen de la Cámara de Diputados). CIEP (2026), *Implicaciones del Paquete Económico 2027*, caps. 5 y 10: cifras del proyecto; el dictamen incluye reasignaciones menores.

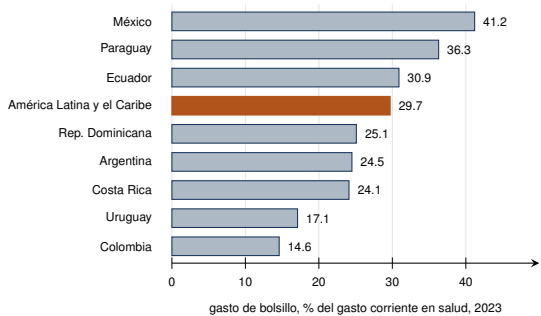
- Un sistema financiado sólo con impuestos generales requiere una recaudación alta y estable.
- México recauda alrededor de **18 %** del PIB, cerca de la mitad de lo que tenían los países que lograron cobertura universal por esa vía.
- Además, cada peso adicional que se recaude compite con las pensiones y con el costo de la deuda.

Con la recaudación actual, una salud universal financiada sólo con impuestos no es viable.

La pregunta es cómo ampliar el aseguramiento, no cómo sustituirlo.

Dos sistemas y el gasto de bolsillo

- En América Latina y el Caribe, **29.7 %** del gasto en salud sale directamente del bolsillo de los hogares. En México es **41.2 %**; en Colombia, **14.6 %**.
- El gasto público en salud de la región es **4.1 %** del PIB. Va de **2.7 %** en México a **6.5 %** en Uruguay.
- Donde conviven un sistema contributivo y otro para quien no cotiza, lo que ninguno de los dos cubre lo paga el hogar, sin planearlo y cuando menos puede.



OMS, Global Health Expenditure Database, y Banco Mundial, 2023: gasto de bolsillo y gasto en salud del gobierno general.

El dilema Gruber

- En un sistema mixto es muy difícil dar el mismo servicio de salud cuando unos contribuyen y otros no.
- Si el servicio es igual para todos, ¿para qué cotizar? Si es distinto, terminamos con dos sistemas.
- Un sistema de salud tiene que lograr dos cosas: que nadie se **empobrezca** por enfermarse, y que **convenga** estar en el sistema contributivo.

En México, como en el resto de la región, se ha avanzado en una o en otra, pero rara vez en las dos al mismo tiempo.

El planteamiento es de Jonathan Gruber (MIT).

El costo de formalizarse

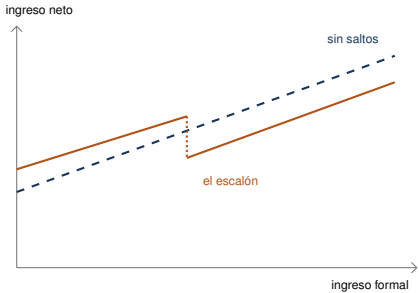
- Al formalizarse, un trabajador empieza a pagar cuotas e impuestos y, en algunos casos, deja de recibir apoyos.
- El Banco Mundial encuentra que, en América Latina, la mayor parte de ese costo corresponde a las **contribuciones de seguridad social**.
- Quién paga realmente las cuotas, el trabajador o la empresa, depende de cómo se ajustan salarios y empleo. Para México no lo tenemos bien medido.
- Lo que sí sabemos es que no todas las cuotas pesan igual: la **cuota fija** pesa proporcionalmente mucho más en los salarios bajos.

Si el trabajador no valora lo que recibe a cambio, la cuota se percibe como un impuesto más. El diseño puede cambiar eso.

Fietz et al. (2025), *(In)Formalizing Jobs in LAC*, Banco Mundial. Detalle de fuentes al final.

El escalón

- Al pasar a un empleo formal, el ingreso neto puede caer: se empiezan a pagar cuotas y se pueden perder apoyos. Ese salto es la **trampa de la formalización**.
- El escalón es más alto en los ingresos medios y bajos, donde la cuota fija pesa más y los apoyos importan más.
- Uruguay reconoció el desincentivo. Desde 2022 suspendió el control del tope de ingreso de sus asignaciones familiares, y entraron **21 mil** hogares adicionales.



Esquema conceptual, sin escala.

Fietz et al. (2025), Banco Mundial; BPS Uruguay, resoluciones 2021–2026; MEF Uruguay, Rendición de Cuentas 2023. Detalle de fuentes al final.

Bismarck, Beveridge y nuestra propuesta

Decisión	Bismarck	Beveridge	Nuestra propuesta
¿Con qué se financia?	Cuotas obrero-patronales	Impuestos generales	Se mantienen las cuotas obrero-patronales; quien no cotiza paga una prima según su ingreso; el gobierno completa
¿La prima es de cada persona?	Sí	No	Sí
¿Quién la paga?	Trabajador y patrón (en México, también el gobierno)	El gobierno	Asalariados, igual que hoy. Los demás, según su ingreso; el gobierno paga la prima completa sólo a los más pobres
¿El derecho depende del pago?	Sí	No, basta con residir	Sí, y todos tienen su prima cubierta

Nuestra propuesta combina de otra manera las mismas cuatro decisiones.

Cómo funcionaría

- Quien tiene empleo formal sigue pagando sus **cuotas obrero-patronales**, como hoy. Lo que cambia es que debe ver con claridad qué paga y qué recibe.
- Quien no cotiza se inscribe en los seguros médicos del IMSS y paga una **prima según su ingreso**. El gobierno completa la diferencia.
- Sólo a la población más pobre el gobierno le paga la prima completa, como un impuesto negativo. Si la pagara para todos, se perdería el incentivo a cotizar.

Todos dentro del mismo sistema de aseguramiento, sin esquemas paralelos.

La propuesta no sube las cuotas obrero-patronales. Con el cambio en Infonavit, la tasa legal sobre la nómina bajaría 3 puntos.

Qué mueve la decisión de formalizarse

Lo que cuesta ser formal

Cuotas de seguridad social: en América Latina son el componente mayor.

Impuestos sobre el ingreso.

Apoyos y servicios no contributivos que se pueden perder.

Lo que recibe a cambio

Salud, pensión, vivienda, guarderías, incapacidades.

Cuenta lo que el trabajador cree que vale, no lo que le cuesta al sistema.

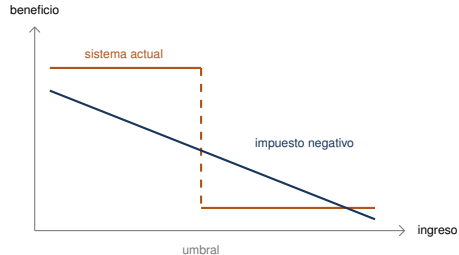
Si la cobertura sin cotizar se parece a la contributiva, cotizar vale menos.

- El costo neto de formalizarse es lo que se paga menos el valor que el trabajador asigna a lo que recibe. Para un asalariado de la región, va de **20** a **40 %** del ingreso del hogar.
- De ahí salen dos reglas de diseño: lo que se recibe debe depender de lo que se cotiza, y la cuota por el mismo ingreso no debe depender de si el trabajo es formal o informal.
- Todavía no hemos estimado cuánto responde la formalidad en México a estos cambios. Lo que sigue es lógica de diseño, no un resultado.

Fietz et al. (2025), *(In)Formalizing Jobs in LAC*, Banco Mundial, cap. 5: mediana en seis países; en México los impuestos pesan más que en el resto.

Consolidar transferencias: un impuesto negativo

- Los programas con límites de ingreso generan un escalón: quien rebasa el límite pierde el apoyo completo.
- Con un **impuesto negativo sobre la renta**, el apoyo baja poco a poco conforme aumenta el ingreso, y formalizarse siempre conviene.
- Esto requiere medir bien los ingresos. La factura electrónica y los pagos digitales ya lo hacen posible en México, Brasil, Uruguay y Colombia.



Esquema conceptual, sin escala.

El impuesto negativo es un puente hacia la contribución propia, no el destino.

Villarreal (2026), CEPAL.

Nuevos instrumentos para financiar la salud

1. Cuotas rediseñadas

Canalizadas a salud, con un vínculo claro entre lo que se paga y lo que se recibe.

Que el trabajador perciba un valor y no un impuesto.

2. Primas según el ingreso

Para quien no cotiza: paga al menos una parte de su prima, proporcional a su ingreso.

El gobierno paga la prima completa sólo a los más vulnerables.

3. Seguros de ciclo de vida

Se pagan durante la vida laboral y cubren el gasto en salud de la vejez.

Descargan al presupuesto público en el largo plazo.

- El gasto privado tiene que ser **prepago** y no gasto de bolsillo. El prepago reparte el riesgo entre muchos y se paga antes de enfermarse.
- Caben también los seguros médicos privados de bajo costo y la atención primaria privada, si se regulan y se conectan con el resto del sistema.

¿Qué reglas necesita el sector privado para participar sin fragmentar el sistema?

Villarreal (2026), CEPAL; Villarreal (2024), «¿Se puede reformar la seguridad social? Parte II», *Arena Pública*.

Cuidados: el siguiente instrumento

- Entre 2025 y 2050, las personas de 80 años y más pasarán de **13** a **37 millones** en la región. A esa edad la dependencia deja de ser ocasional y el cuidado puede volverse permanente.
- Pensiones, salud y cuidados compiten por el mismo espacio presupuestario. Conviene analizarlos como un solo sistema.
- Hay instrumentos posibles: un seguro que se pague durante la vida laboral y cubra en la vejez, con un fondo solidario como base y con espacio para que lo público y lo privado se complementen.

¿Puede un seguro pagado durante la vida laboral financiar los cuidados de la vejez?

Población de 80 años y más: proyección propia (detalle al final). Villarreal (2026), CEPAL; Villarreal (2024), *Arena Pública*.

Dos preguntas para cualquier propuesta

1. ¿Se puede pagar durante toda la transición demográfica sin que la deuda se vuelva insostenible?
2. ¿Fortalece o debilita el incentivo a cotizar?

Si una propuesta falla en alguna de las dos, tiene un problema de fondo. Esto aplica a lo que propongo y a cualquier alternativa. Para contestar la primera hay que hacer la cuenta completa: salud, pensiones y reforma fiscal juntas.

El nacimiento de CONOSAFI

- **Por qué nace.** En la región se ha discutido mucho cómo ampliar la cobertura, y mucho menos cómo pagarla en los próximos veinte o treinta años.
- **Quién la funda.** Tres instituciones:
  - Tecnológico de Monterrey — coordinación, Héctor Villarreal
  - Universidad de los Andes, Colombia — Ramiro Guerrero
  - Pontificia Universidad Católica de Chile — Pablo Celhay
- **Cuándo.** Se anunció en el Seminario Regional de Política Fiscal de la CEPAL, en mayo de 2026. La primera reunión de trabajo fue en San José, Costa Rica, del 5 al 7 de octubre de 2026.
- **Hacia dónde va.** Tiene un horizonte de al menos cinco años y tres trabajos en curso, uno por cada institución fundadora.

CONOSAFI: Comunidad Latinoamericana de Conocimiento en Sistemas de Salud y Financiamiento.

Una agenda para la RIUSS

Cinco preguntas abiertas:

1. ¿Qué parte del gasto de bolsillo podría convertirse en prepago?
2. ¿Con qué reglas el financiamiento privado complementa al público en lugar de debilitarlo?
3. ¿Cuánto puede ahorrar la detección temprana cuando las enfermedades son crónicas?
4. ¿Cuánto espacio dejan las pensiones para financiar la salud en los próximos veinte años?
5. ¿Con qué instrumentos se van a financiar los cuidados de largo plazo?

Buscamos investigadores y datos comparables en la región.

¿Podemos diseñar sistemas de protección social que la gente valore lo suficiente para querer participar, y que nuestros países puedan pagar durante su transición demográfica?

Héctor Juan Villarreal Páez · hjvp@itesm.mx
ITED · Escuela de Gobierno y Transformación Pública · Tecnológico de Monterrey

Fuentes (1/2)

Demografía de la región. Proyección propia de la población de América Latina y el Caribe (49 países y territorios), 2025–2060, por componentes, en grupos quinquenales de edad. La fecundidad de cada país se mantiene en su último valor observado: registros nacionales de 2022 a 2025 para 18 países, reunidos por Fernández-Villaverde, J. (2026), *A Recent Population History of Latin America and the Caribbean*; México, 1.23 hijos por mujer (INEGI, Encuesta Intercensal 2025); en los demás países, la estimación de Naciones Unidas para 2025. Población base de México: INEGI, Encuesta Intercensal 2025. Población base de los demás países, mortalidad, migración y patrón de fecundidad por edad: Naciones Unidas, DESA, *World Population Prospects 2024*, variante media. Con la fecundidad de Naciones Unidas, el mismo cálculo da 729 millones en 2050 (publicado: 730) y el cruce entre mayores de 65 y menores de 15 hacia 2046. Fernández-Villaverde, J. (2023), *The Demographic Future of Humanity: Facts and Consequences*.

Caída de la fecundidad. Villarreal, H. (2026), «Cohort Replacement, Not Cascade: Union Composition and the Rapid Fertility Collapse in Latin America», documento de trabajo, Tecnológico de Monterrey: registros vitales de INEC (Costa Rica) y DANE (Colombia); DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2008–2024.

Velocidad del envejecimiento. Cálculo propio con *World Population Prospects 2024*: años entre 10 % y 20 % de población de 65 años y más. Para América Latina y el Caribe, proyección propia.

Pensiones. Villarreal, H. (2026), «América Latina necesita una nueva seguridad social», XXXVIII Seminario Regional de Política Fiscal, CEPAL, Santiago, mayo de 2026. Chile: Ley 21.735, publicada el 26 de marzo de 2025; Ministerio de Hacienda de Chile (2025). Colombia: Ley 2381 de 2024; Corte Constitucional de Colombia (2026). CEPALSTAT, ocupados que aportan o están afiliados a sistemas de pensiones, 2023–2024 (Argentina no está disponible en la misma serie). OIT, *Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe*.

Gasto en salud y gasto de bolsillo. OMS, Global Health Expenditure Database, y Banco Mundial, datos de 2023: gasto en salud del gobierno general como % del PIB y gasto de bolsillo como % del gasto corriente en salud.

México: carga de enfermedad, presupuesto 2027, salud y pensiones. PEF 2027: dictamen de la Cámara de Diputados. CIEP (2026), *Implicaciones del Paquete Económico 2027*, 11 de septiembre de 2026: gasto en salud, carga de enfermedad (IHME, 2021; OMS, 2024), prima de equilibrio del IMSS (IMSS, 2024), pensiones y Miscelánea; sus cifras corresponden al proyecto de presupuesto. Meta de 6 % del PIB: OPS (2014), *Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud*.

México: espacio disponible. Villarreal, *Contabilidad de la Muerte*, actualización con el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública enero–septiembre 2026 (SHCP) y los Criterios Generales de Política Económica 2027. PIB nominal de 36,500 mmdp; el supuesto favorece a la cuenta oficial.

Fuentes (2/2)

Reforma fiscal clásica en México. Estimación propia del rendimiento de un paquete de reforma clásica (IVA, ISR y gastos fiscales), alrededor de 1.5 puntos del PIB.

Trampa de la formalización. Fietz, Joubert, Ñopo, Ocampo, Packard, Posadas y Rodriguez Chamussy (2025), *(In)Formalizing Jobs in Latin America and the Caribbean: Taxes, Benefits, and Labor Market Incentives*, Banco Mundial, cap. 5. Uruguay: Banco de Previsión Social, resoluciones de directorio 2021–2026; Ministerio de Economía y Finanzas, Rendición de Cuentas 2023.

Modelo de aseguramiento, instrumentos y metas de financiamiento. Villarreal, H. (2026), CEPAL. Villarreal, H. (2024), «¿Se puede reformar la seguridad social? Parte II», *Arena Pública*, 10 de septiembre de 2024. Dilema de Gruber: Jonathan Gruber (MIT).

Cuota fija (apéndice). Ley del Seguro Social, art. 106, fr. I. IMSS, *Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS 2025–2026*: cuota fija patronal de 20.40 % de la UMA. INEGI, UMA 2026: 117.31 pesos diarios. CONASAMI, salario mínimo general 2026: 315.04 pesos diarios.

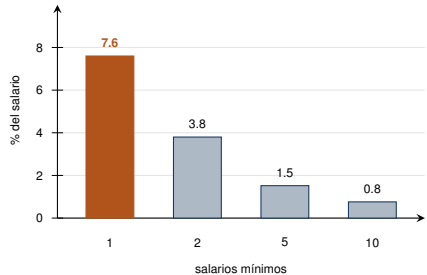
Infonavit (apéndice). Ejercicio propio, preliminar, sobre tasas legales. No es una propuesta del IMSS ni del Gobierno Federal. Antecedente: Villarreal, H. (2022), «El Infonavit, ¿qué sigue?», *Arena Pública*, 20 de diciembre de 2022.

Arquitectura institucional en México (apéndice). Diario Oficial de la Federación: 29-XI-2019 (Insabi), 31-VIII-2022 (IMSS-Bienestar), 29-V-2023 (reforma a la Ley General de Salud).

CONOSAFI. Comunidad Latinoamericana de Conocimiento en Sistemas de Salud y Financiamiento: nota de presentación (octubre de 2026) y documento de presentación de la iniciativa; reunión de trabajo en San José, Costa Rica, 5–7 de octubre de 2026.

Apéndice · México: la cuota fija pesa más donde menos se gana

- En el seguro de enfermedades y maternidad, el patrón paga por cada trabajador una cuota fija de **20.40 %** de la UMA, sin importar el salario.
- Para un trabajador de un salario mínimo, esa cuota equivale a **7.6 %** del salario. Para uno de diez salarios mínimos, a **0.8 %**.
- La parte de la cuota que distorsiona es la que no guarda relación con lo que el trabajador recibe, y se concentra en los salarios bajos.



Cuota fija patronal como % del salario. Valores de 2026: UMA de 117.31 pesos diarios y salario mínimo general de 315.04.

Ley del Seguro Social, art. 106, fr. I; IMSS, *Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2025–2026*; INEGI, UMA 2026; CONASAMI, salario mínimo general 2026. Cálculos propios.

Apéndice · México, Infonavit: la propuesta

Qué se propone

Eliminar la aportación patronal de **5 %** del salario base de cotización al Infonavit.

Destinar **2 puntos** a un seguro solidario de salud y cuidados en la vejez: un fondo común, no cuentas individuales. Primero cubre el déficit de los gastos médicos de pensionados; lo que sobra va a cuidados de largo plazo.

Los otros **3 puntos** se dejarían de cobrar: la tasa legal sobre la nómina baja 3 puntos.

El Instituto y los trabajadores

El Infonavit conserva su patrimonio y sus obligaciones como mutualidad.

El trabajador deja de acumular 5 % de su salario en la subcuenta de vivienda y recibe a cambio un seguro.

Quien no usa crédito tendría menos saldo para su pensión. Ese efecto no lo hemos cuantificado, y tampoco el efecto sobre la formalidad.

El seguro de gastos médicos de pensionados del IMSS ya es deficitario, y el envejecimiento presiona justo ahí.

Ejercicio propio, preliminar; no es una propuesta del IMSS ni del Gobierno Federal. Son tasas legales: no miden quién soporta la cuota. Antecedente: Villarreal (2022), «El Infonavit, ¿qué sigue?», *Arena Pública*.

Apéndice · México: el IMSS como sistema nacional de seguros de salud

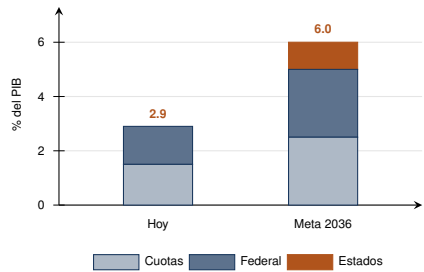
- Partimos de lo que existe. El IMSS tiene los hospitales, el personal, buena parte de la formación de especialistas y el registro de derechohabientes. Para la población sin seguridad social, en cambio, el modelo cambió tres veces entre **2019** y **2023**.
- Que el IMSS agrupe los servicios de salud ligados al empleo formal: ISSSTE, Pemex e incluso fuerzas armadas.
- Que se dedique sólo a salud. Pensiones y cuidados, en otras instancias.
- Que pueda funcionar como caja de compensación y contratar servicios privados con recursos públicos.

Diario Oficial de la Federación, 29-XI-2019, 31-VIII-2022 y 29-V-2023; Villarreal (2024). Detalle de fuentes al final.

Apéndice · México: ¿de dónde saldría el 6 % del PIB?

- **Cuotas de salud:** de **1.5 %** a **2.5 %** del PIB, con el crecimiento de la masa salarial y la formalización.
- **Gobierno federal**, sin contar cuotas: de **1.4 %** a **2.5 %**, sumando **0.1** puntos cada año. La fuente serían los gastos fiscales.
- **Estados y Ciudad de México: 1 %** del PIB, con participaciones e ingresos propios, sobre todo predial.

Nada de esto funciona si no se contiene el gasto en pensiones.



Hoy: aportación estatal propia no desglosada.

Villarreal (2024), «¿Se puede reformar la seguridad social? Parte II», *Arena Pública*.

Apéndice · México: salud en el presupuesto 2027

- El gasto en salud aumenta **10.6 %** real y llega a **1.14 billones** de pesos. Si se descuenta la inflación de los servicios médicos, el aumento es de **8.6 %**.
- El **75.6 %** del aumento se va a población con seguridad social: IMSS crece **11.6 %**, ISSSTE **18.8 %** e IMSS-Bienestar **9.0 %**.
- De ese total, **760 mil millones** (**67 %**) son para la población con seguridad social y **376 mil millones** (**33 %**) para el resto. Para el resto, el aumento es de **7.6 %** real.

El aumento recupera parte de los recortes recientes, pero la estructura sigue igual.

PEF 2027 (dictamen de la Cámara de Diputados). CIEP (2026), *Implicaciones del Paquete Económico 2027*, cap. 5, con base en SHCP: cifras del proyecto; el dictamen incluye reasignaciones menores.